

ITEM 233 : PÉRICARDITE AIGUË

Péricardite = inflammation du péricarde : - **Aiguë** < 4 à 6 semaines - **Récurrente** : après un intervalle libre > 4-6 semaines
 - **Prolongée** > 4-6 semaines - **Chronique** > 3 mois

Etiologie	Virale ou idiopathique (90%)	- Virus (rarement retrouvé) : entérovirus (coxsackie A et B), échovirus, adénovirus, CMV, parvovirus B19, EBV, herpès, VIH, hépatite C, influenza... - Tableau typique : - Sujet jeune - Précédé d'un épisode viral - Début brutal, fébrile, avec ETT généralement normale - Epanchement pleural souvent associé - Diagnostic : sérologies (non systématique), PCR sur ponction péricardique (peu réalisée) - Pronostic principal : rechute ou récurrence (30-50%)
	Tuberculose	- Tableau : subaigu, associé à une AEG et à une fièvre modérée - Diagnostic : recherche de BK (tubages gastriques, expectoration ou liquide pleural), $\nearrow$ adénosine désaminase pleurale, IDR/Quantiféron $\pm$ granulome à la ponction péricardique - Risque évolutif : tamponnade, récurrence, péricardite constrictive
	Péricardite purulente	- Germe : staphylocoque (post-chirurgical), pneumocoque, Haemophilus, BGN, méningocoque, légionelle, fongique (sujet immunodéprimé) ou parasitaire - Contexte : chez l'immunodéprimé ou post-chirurgie cardiaque ou thoracique - Complications : tamponnade, péricardite constrictive - TTT : - Antibiothérapie adaptée à la ponction péricardique - Drainage chirurgical souvent nécessaire
	Post-infarctus	- Précoce (J3-J5) : en cas d'IDM étendu avec infarctus transmural, d'évolution favorable - Tardif (2 à 16 semaines) = syndrome de Dressler : péricardite, fièvre, AEG, arthralgie, épanchement pleural gauche, syndrome inflammatoire biologique important, allongement du QT
	Péricardite néoplasique	= Tumeur primitive (= mésothéliome péricardique, rare), extension par contiguïté (sein, poumon), métastase (sarcome de Kaposi, mélanome) ou hémopathie maligne (lymphome) - Diagnostic : - ETT $\pm$ TDM/IRM (tumeur péricardique) - Ponction péricardique $\pm$ biopsie péricardique indispensable : diagnostic de malignité - Risque évolutif immédiat : hémopéricarde, tamponnade
	Maladie systémique	= Lupus, PR, sclérodermie, périartérite noueuse, dermatomyosite... : diagnostic d'élimination - Diagnostic : $\nearrow$ lymphocytes, Ac anti-sarcoleme dans le liquide péricardique, myocardite associée
	Post-chirurgie cardiaque	- Syndrome post-péricardotomie : inflammation dans les jours/mois suivant une chirurgie cardiaque ou après transplantation cardiaque, risque de tamponnade et de péricardite constrictive (1^{ère} cause) - Hémopéricarde post-opératoire : précoce
	- VIH : virale, lymphome, sarcome de Kaposi, surinfection fongique ou bactérienne - Dissection aortique avec tamponnade - IRC terminale : - Péricardite urémique chez le patient non dialysé : exsudat - Péricardite de l'hémodialysé : transsudat, par traitement épurateur inadapté - Autres : pancréatite, myxoedémateuse (hypothyroïdie), médicament (hydralazine, pénicilline), post-radique, RAA	
Diagnostic	SF	- Douleur thoracique : - Précordiale ou rétro-sternale, à type de brûlure ou constrictive, prolongée, parfois intense - $\nearrow$ par la toux, l'inspiration profonde et par le décubitus et $\searrow$ par l'antéflexion - Fièvre modérée : présente d'emblée $\pm$ syndrome pseudo-grippal en cas de péricardite virale - Signes respiratoires ($\searrow$ par l'antéflexion) : dyspnée, toux sèche, dysphonie, hoquet
	SC	- Frottement péricardique : - Inconstant, fugace, d'intensité variable - Systolo-diastolique à 3 temps : proto-diastolique, pré-systolique et systolique - Persiste en apnée : diagnostic différentiel avec un frottement pleural - Assourdissement des bruits du cœur - Signes d'insuffisance cardiaque droite : suspecter une tamponnade
	Bio	- Bilan standard : NFS, CRP, troponine et CPK ($\nearrow$ si myocardite associée), iono, urée, créat, bilan hépatique - Sérologie VIH avec accord du patient - Autre : IDR si suspicion de BK, hémoculture si fièvre, bilan auto-immun si suspicion de MAI

Diagnostic	PC	ECG	= Anomalies diffuses non systématisées, en 4 stades successifs = tétrade d'Holtzman : - Sus-décalage du segment ST : diffus, concave vers le haut, souple, sans signe en miroir - Retour à la ligne isoélectrique du segment ST et aplatissement des ondes T entre 24 et 48h - Négativisation des ondes T de façon circonférentielle (= restent asymétriques), la 1 ^{ère} semaine - Retour à la ligne isoélectrique du segment ST et des ondes T au cours du 1 ^{er} mois - Autres : - Micro-voltage diffus : QRS < 5 mm en dérivation périphérique ou < 10 mm en précordial - Sous-décalage du segment PQ (repolarisation auriculaire): précoce, très évocateur - Troubles du rythme supra-ventriculaire fréquents : tachycardie sinusale, ESA, FA, flutter → ECG possiblement normal, à répéter	
		RP	- Anormale en cas d'épanchement péricardique abondant : cardiomégalie symétrique en « carafe » - Orientation : lésions tuberculeuses, opacité pulmonaire néoplasique, calcification péricardique ou pleural, épanchement pleural souvent associé (= pleuro-péricardite)	
		ETT	- Epanchement péricardique (parfois minime) : espace clair vide d'écho, parfois minime → L'absence d'épanchement n'exclut pas le diagnostic : péricardite sèche - Masse péricardique : MT ou caillot de péricardite néoplasique - Trouble de cinétique ventriculaire global ou segmentaire : myocardite associée	
		Autre	- IRM cardiaque : si suspicion de myocardite associée ou de tumeur péricardique - TDM cardiaque : si doute diagnostique (visualise l'épanchement péricardique) ou tumeur péricardique - Ponction péricardique indiquée si : - Tamponnade - Forte suspicion de péricardite néoplasique - Epanchement péricardique abondant > 2 cm, symptomatique, persistant sous traitement > 1 semaine - Drainage péricardique chirurgical : en cas de suspicion de péricardite purulente	
	Critères diagnostiques de péricardite aiguë		≥ 2 critères/4 : - Douleur thoracique - Frottement péricardique à l'auscultation - Signes ECG - Epanchement péricardique à l'ETT	
Complications	Tamponnade		= Epanchement péricardique dans un espace non expansif → adiastolie aiguë → Le risque dépend de l'importance et de la rapidité de constitution de l'épanchement	
		Cause	- Péricardite néoplasique : 30% des tamponnades - Hémopéricarde : dissection aortique, post-traumatique/chirurgical, ponction péricardique, biopsie endo-myocardique, pacemaker, ablation d'électrode épicaudique - Autres : urémique (10%), IDM (10%, notamment après thrombolyse), viral (exceptionnel)	
		Diagnostic	- Douleur thoracique inconstante - Dyspnée positionnelle, polypnée puis orthopnée, toux - Tachycardie, pouls paradoxal (↘ de PA > 10 mmHg à l'inspiration), bruits du cœur assourdis - Tableau de choc avec signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë	
			ECG	- Signe de péricardite avec micro-voltage - Alternance électrique : alternance de QRS micro-volté et de voltage augmenté
			RP	- Contribution diagnostic faible : cardiomégalie symétrique en « cœur en sabot »
			ETT	- Epanchement péricardique : circonférentiel, au sein duquel le cœur paraît petit avec une contraction vigoureuse (aspect « <i>swinging heart</i> ») - Compression des cavités droites avec collapsus du VD et de l'OD
	TTT	→ Urgence thérapeutique : transport demi-assis - Drainage chirurgical par sternotomie : drain péricardique, analyse du liquide et biopsie - Ponction péricardique si état critique ou en attente de drainage chirurgical → Contre-indication absolue en cas de dissection aortique → Contre-indication relative en cas de trouble de coagulation ou d' épanchement localisé - Traitement médical associé : remplissage vasculaire (colloïde) ± inotrope		
Myocardite	- Péricardite avec ↗ troponine et CPK - Insuffisance cardiaque fébrile , voire état de choc (myocardite fulminante) - Cause : généralement virale ou idiopathique - IRM cardiaque : rehaussement tardif non systématisé, plutôt sous-épicaudique - Coronarographie systématique pour éliminer un SCA			
Péricardite récidivante	= 30 à 50% de récides pour les péricardites virales : fréquente entre 3 mois et 3 ans - Prévention : traitement prolongé avec diminution progressive, colchicine			

Complications	Péricardite chronique	= Problème étiologique (surtout en l'absence de contexte évocateur de péricardite virale) - Cause : péricardite néoplasique (principalement), péricardite tuberculeuse - Péricardoscopie par fibres optiques avec prélèvement biopsique dirigé possible	
	Péricardite constrictive	= Epaississement fibreux ou fibro-calcaire du péricarde (± visible au TDM) - Causes principales : péricardite tuberculeuse , post-radique , purulente , IRC ou post-sternotomie	
		Diagnostic	- Episodes d'insuffisance cardiaque droite à répétition avec dyspnée, prise de poids, OMI, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, voire anasarque - RP : calcifications péricardiques, sans cardiomégalie - ECG : micro-voltage, trouble de repolarisation, FA , troubles de conduction - ETT : dilatation des oreillettes avec taille normal des ventricules, septum paradoxal, péricarde épaissi, dilatation de la VCI et des veines sus-hépatiques - TDM/IRM cardiaque : visualisation du péricarde épaissi et calcifié - Cathétérisme cardiaque droit : aspect caractéristique de <i>dip</i> plateau de la pression du VD
		TTT	- Préventif : - Drainage correct des péricardites purulentes avec lavage - Corticoïdes : diminuerait le risque de péricardite constrictive post-tuberculeuse - TTT chirurgical curatif : décortication péricardique (résultats inconstants)
TTT	→ Prise en charge ambulatoire possible si : - Risque de tamponnade faible : épanchement < 20 mm - Patient compliant (suivi) - Sans comorbidité - Suspicion d'étiologie virale/idiopathique - Sans myocardite associée - Hospitalisation et bilan étiologique si : suspicion d'étiologie non virale, fièvre élevée, survenue subaiguë, épanchement péricardique abondant > 2 cm, tamponnade, myocardite, immunodépression, traumatisme, anticoagulant oral ou échec du traitement ambulatoire > 1 semaine		
	Péricardite aiguë bénigne	= Traitement prolongé pendant 1 mois , jusqu'à normalisation de la CRP, avec arrêt progressif - Repos au lit non strict avec arrêt de travail et restriction de l'activité physique → Contre-indication à toute anticoagulation à dose curative : risque d'hémopéricarde	
		AINS/Aspirine	= Traitement par AINS ou aspirine à dose anti-inflammatoire pendant 1 mois (avec décroissance progressive sur les 1-2 dernières semaines) - Aspirine à dose anti-inflammatoire : 750 à 1000 mg/8h, soit 1,5 à 3 g/jour - Ibuprofène : 600 mg/8h, soit 1,8 g/j - Indométacine possible en cas de péricardite aiguë récurrente ± IPP associé, surtout si aspirine à 3 g/j, atcds de RGO/ulcère ou signes digestifs
		Colchicine	= Systématiquement associé (voire en monothérapie), sur une durée de 3 mois - A faible dose (0,5 mg x 2/jour) : action antalgique et diminue le risque de récurrence - Précautions : - Interactions médicamenteuses (macrolide, ciclosporine, statine...) - A demi-dose si < 70 kg, > 70 ans ou insuffisance rénale avec DFG > 35 - EI : diarrhée ++ - Surdosage : troubles digestifs, paralysie, cytopénie, alopecie, atteinte rénale, convulsion - Contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère < 35 ml/min ou d'IHC sévère
		Corticoïdes	= A faible dose, possible en 2 nd intention si contre-indication aux AINS/aspirine et à la colchicine, après avoir éliminé une cause infectieuse
		Suivi	- Visite de contrôle à 7 jours  - Contrôle échographique : toutes les semaines si épanchement modéré ou à 1 mois si minime
	Péricardite récurrente	- Aspirine/AINS et colchicine sur une durée prolongée jusqu'à 6 mois en 1 ^{ère} intention - Corticoïdes à faible dose en 2 nd intention - En dernière intention : immunoglobulines IV , anakinra , azathioprine voire péricardotomie	
	Péricardite purulente	- Drainage chirurgical avec mise en place d'un gros drain ± antibiothérapie local - Antibiothérapie générale prolongée	
	Péricardite tuberculeuse	- Traitement antituberculeux classique - Corticoïdes en prévention de la péricardite constrictive (sauf en cas d'infection VIH associée)	
	Péricardite néoplasique	- Drainage transcutané ± chirurgical avec analyse - Prise en charge de la néoplasie	